



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN HASIL KEGIATAN
PELATIHAN *MEDICATION ERROR*
TAHUN 2024**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keputusan penggunaan obat selalu mengandung pertimbangan antara manfaat dan risiko. Fokus pelayanan kefarmasian bergeser dari kepedulian terhadap obat (*drug oriented*) menuju pelayanan optimal setiap individu pasien tentang penggunaan obat (*patient oriented*). Untuk mewujudkan *pharmaceutical care* dengan risiko yang minimal pada pasien dan petugas kesehatan perlu penerapan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah bagian yang mendasar dari tanggungjawab pemberian pengobatan. Pesatnya perkembangan teknologi farmasi yang menghasilkan obat-obat baru juga membutuhkan perhatian akan kemungkinan terjadinya risiko efek samping pada pasien. Manajemen obat mencakup sistem dan proses yang digunakan rumah sakit dalam memberikan farmakoterapi kepada pasien.

Medication Error atau kesalahan pelayanan obat merupakan setiap kejadian yang dapat dihindari yang menyebabkan atau berakibat pada pelayanan obat yang tidak tepat atau membahayakan pasien sementara obat berada dalam pengawasan tenaga kesehatan atau pasien. *Medication error* dapat terjadi dimana saja dalam rantai pelayanan obat kepada pasien mulai dari produksi dalam peresepan, pembacaan resep, peracikan, penyerahan dan monitoring pasien. Di dalam setiap mata rantai ada beberapa tindakan, sebab tindakan mempunyai potensi sebagai sumber kesalahan. Setiap tenaga kesehatan dalam mata rantai ini dapat memberikan kontribusi terhadap kesalahan.

Rumah sakit mempunyai proses untuk mengidentifikasi dan melaporkan kesalahan obat. Proses pelaporan adalah bagian dari program mutu dan keselamatan pasien rumah sakit meliputi pelaporan medication error (insiden keselamatan pasien) serta pelaporan monitoring efek samping obat dan reaksi obat yang tidak dikehendaki. Perbaikan dalam manajemen pengobatan secara terpadu digunakan untuk mencegah kesalahan di kemudian hari. Demi mencegah terjadinya *medication errors* maka diperlukan pelatihan secara berkala mengenai pemahaman dan pelaporan *medication error* oleh tenaga kesehatan.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 3.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.

1.3 Tujuan

1. Tujuan Umum
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tenaga kesehatan tentang medication error.
 2. Tujuan Khusus
 - a. Meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan terhadap pemahaman dan mekanisme pelaporan medication error.
 - b. Menurunkan Insiden Keselamatan Pasien dalam medication error serta meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- 

BAB II
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Susunan Panitia

NO	SUSUNAN PANITIA	NAMA	TUGAS
1	Ketua Panitia	apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara. Hasil akhir : LPJ
2	Moderator	apt. Asharul Fahrizi, S.Farm	Bertanggung jawab sebagai moderator dan mengaktifkan tanya jawab peserta. Hasil akhir : ringkasan persesi dan tanya jawab
3	Absensi	Apt. Septiani Tri Ayuningsih, S. Farm	Bertanggungjawab terhadap kelengkapan absensi dan menyiapkan serta membagikan kuisisioner pelatihan. Hasil akhir : rekap absensi dan kuisisioner pelatihan
4	Sekretaris	apt. Pipin Purwa Ningrum, S.Farm	bertanggung jawab terhadap pendokumentasian seluruh dokumen dan notulen. Hasil akhir : 1) notulen 2) LPJ
5	Sie Dokumentasi	apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm	bertanggung jawab sebagai fotografer. Hasil akhir : foto di LPJ
6	Sie Perlengkapan	apt. Asharul Fahrizi, S.Farm	bertanggung jawab terhadap kelengkapan peralatan, peminjaman, dan pengembalian alat. Mengambilkan alat-alat yang belum tersedia saat acara
7	Sie Penunjang	apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm	bertanggung jawab mengkoordinir peserta untuk patuh dengan jadwal pelatihan

2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Pelatihan *Medication Error* dilaksanakan 1 (satu) hari dibagi menjadi 2 gelombang

- 1. Tanggal : 17 Oktober 2024
- 2. Pukul : Gelombang I : 08.00 s/d 10.00 WIB
Gelombang II : 10.00 s/d 12.00 WIB
- 3. Tempat : Hall Sakura Lantai 5 Rumah Sakit Prima Husada Malang

2.3 Sasaran atau Peserta

- 1. Dokter
- 2. Farmasi
- 3. Perawat
- 4. Bidan

GELOMBANG I	GELOMBANG II
-------------	--------------

NO	PESERTA	JUMLAH	NO	PESERTA	JUMLAH
1	Dokter	50	1	Dokter	0
2	Perawat	81	2	Perawat	79
3	Bidan	11	3	Bidan	13
4	Farmasi	17	4	Farmasi	26
Total		159	Total		118

2.4 Narasumber/ Pemateri

dr. Ari Putriani, Sp.PK

2.5 Susunan Acara

JAM	DURASI	MATERI	PEMATERI
Gelombang I			
08.00-08.05	5 menit	Pretest	Tim
08.05-09.55	80 menit	Materi 1. <i>Medication Safety</i> 2. <i>Pelaporan Medication Error</i>	dr. Ari Putriani, Sp.PK
	30 menit	Tanya Jawab	Tim
09.55-10.00	5 menit	Post test	Tim
Gelombang II			
10.00-10.05	5 menit	Pretest	Tim
10.05-11.55	80 menit	Materi 1. <i>Medication Safety</i> 2. <i>Pelaporan Medication Error</i>	dr. Ari Putriani, Sp.PK
	30 menit	Tanya Jawab	Tim
11.55-12.00	5 menit	Post test	Tim

2.6 Media

Media yang digunakan:

- a. Laptop
- b. LCD
- c. Sound System
- d. Platform

2.7 Metode

Metode yang digunakan:

- 1. Diskusi
- 2. Ceramah
- 3. Demonstrasi
- 4. Role Play
- 5. Tanya Jawab

2.8 Anggaran

NO	DESKRIPSI	JUMLAH SATUAN	TOTAL
1.	Air minum @Rp 21.000	4 Kardus	Rp. 84.000
Total Biaya			Rp. 84.000

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

3.1 Monitoring

1. Persiapan alat dan link zoom pelatihan serta materi sudah berjalan dengan baik. Pemateri dan panitia hadir tepat waktu, namun beberapa peserta online tidak mengikuti zoom pelatihan dan beberapa peserta offline datang terlambat, akibatnya pelaksanaan mundur kurang lebih 10 menit dari waktu yang dijadwalkan.
2. Sambil menunggu semua peserta bergabung, peserta lain di berikan kesempatan untuk mengisi link *pre-test* yang dibagikan melalui scan barcode pada *powerpoint* yang ditampilkan dan kolom chat aplikasi zoom (bagi peserta online). Total keterisian *pre-test* dari keseluruhan yang hadir yaitu 62.1%
3. Pemateri memberikan materi dengan Bahasa yang mudah dipahami oleh peserta dan memberikan contoh-contoh kasus yang terjadi di lapangan.
4. Peserta tenang dan memperhatikan jalannya pemberian materi dengan baik.
5. Beberapa peserta terpaksa harus keluar dari ruang pelatihan pada pertengahan materi dikarenakan kondisi ruangan yang tidak bisa ditinggal terlalu lama.
6. Pelatihan di akhiri proses diskusi tanya jawab dan klarifikasi dari peserta terkait kasus yang terjadi di lapangan.
7. Total keterisian *post-test* dari keseluruhan yang hadir yaitu 60.6%.
8. Pelaksanaan evaluasi secara berkala dilakukan oleh Kepala bidang pelayanan medis, Kepala bidang penunjang medis, Kepala bidang keperawatan dan Kepala unit masing-masing dengan memonitoring setiap staf setiap hari.

3.2 Evaluasi

1. Jumlah keseluruhan daftar undangan sebanyak 277 orang yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, apoteker dan TTK. Daftar undangan tersebut dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang 1 yang hadir sebanyak 100 peserta dari 159 undangan peserta, Gelombang 2 yang hadir sebanyak 83 peserta dari 118 undangan peserta,
 2. Peserta pelatihan *medication error* yang mengikuti pre test dan post test adalah sebanyak 172 dari 277 undangan peserta. Dari data 172 peserta yang mengikuti pre test dan post test, sebanyak 138 peserta dinyatakan LULUS.
 3. Pelaksanaan evaluasi di lapangan tetap wajib dilakukan secara berkala oleh pimpinan mulai dari Kepala bidang pelayanan medis, Kepala bidang penunjang medis, Kepala bidang keperawatan dan Kepala unit masing-masing.
- 

BAB IV PENUTUP

Demikian laporan ini kami buat. Kami mengharapkan dukungan dan kerjasama dalam evaluasi karyawan secara berkala setelah diadakan pelatihan ini. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan.

Menyetujui,
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

Malang, 18 Oktober 2024
Hormat kami,



apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm



LAMPIRAN

